

脳神経内科医が答える からだの不思議 #03

# 「手がしびれて 目が覚めた」の正体

— 朝のしびれの原因と受診のタイミング —

---

医知創造ラボ 今村久司

脳神経内科専門医

# こんな経験ありませんか？

「夜中に手がしびれて目が覚めた。  
手を振ったら治ったけど、また繰り返す」

「朝起きると手がジンジンしている。  
特に親指・人差し指・中指が気になる」

「横向きに寝ていたら、朝に手首が下がって  
力が入らなくなった」

外来でよく相談を受ける症状 — 原因は1つではありません

# しびれとは何か — 神経で何が起きているか

## しびれの種類

ジンジン感（異常感覚） ／ 感覚が薄くなる（感覚鈍麻） ／ ピリピリ感 ／ 力が入らない

### 末梢神経

手足・体幹の  
末端を走る神経

### 脊髄・神経根

背骨の中を通る  
中枢から末梢への中継点

### 脳（中枢）

大脳・視床・  
感覚野の障害

重要：しびれの「場所のパターン」でどの神経か特定できる — これが鑑別の核心

# 鑑別の最初的一步 — 「どの指か」を確認する

## 正中神経

(せいちゅうしんけい)

担当エリア

親指・人差し指・中指・薬指の半分

経路：手根管を通る

## 尺骨神経

(しゃっこつしんけい)

担当エリア

小指・薬指の半分

経路：肘の内側を通る

## 橈骨神経

(とうこつしんけい)

担当エリア

手背・親指～中指の背側

経路：上腕部を走る

**KEY:** 「小指が入るかどうか」が最初の分岐点

# 最も多い原因 — 手根管症候群（しゅこんかんしょうこうぐん）

手首の正中神経が「手根管」というトンネルで圧迫される疾患

特に40～60代の女性に多い（妊娠中・透析患者でも起こりやすい）



## しびれる場所

親指・人差し指・中指  
（小指にはしびれなし！）



## 悪化するとき

夜間～早朝に強くなる  
手首を曲げた寝姿勢で悪化



## Flick sign

手を振る・腕を高く上げると  
一時的に楽になる

筋萎縮が起きてからでは回復に時間がかかる — 気になり始めたら早めに受診を

# 小指・薬指のしびれ — 肘と首の問題

## 肘部管症候群（ちゅうぶかんしょうこうぐん）

障害神経: 尺骨神経（しゃっこつしんけい）

部位: 肘の内側で圧迫

しびれ: 小指・薬指（半分）

悪化: 肘を曲げ続けると悪化  
（横向き就寝時も）

進行: 手の筋肉がやせる  
「鷲手（わしで）変形」

## 胸郭出口症候群（きょうかくでぐちしょうこうぐん）

障害神経: 腕神経叢（うでのしんけいそう）

部位: 鎖骨と第一肋骨の間に圧迫

しびれ: 小指・薬指側・前腕内側

悪化: 腕を上げたとき  
（ドライヤー・つり革）

特徴: なで肩・首が長い女性に多い  
肩こりを伴うことが多い

# 首から来るしびれ・翌朝の麻痺

## 頸椎症性神経根症（けいついしょうせいしんけいこんしょう）

原因: 頸椎の骨・椎間板の変性  
↓ 神経根（しんけいこん）を圧迫

年齢: 50歳以降に多い  
（デスクワーク・スマホ負担）

しびれ: 手指～前腕～上腕まで広がる

診断: 首の後屈で悪化  
（Spurlingテスト）

## Saturday night palsy（橈骨神経麻痺）

原因: 上腕部の橈骨神経（とうこつしんけい）を  
圧迫したまま眠った翌朝に出現

症状: 手首が下がる「下垂手（かすいしゅ）」  
手首・指が持ち上げられない

経過: 多くは数週間～数か月で  
自然回復する

予防: 飲酒後に固い台で腕を圧迫  
して眠らないよう注意

頸椎症はしびれが手だけでなく前腕・上腕まで広がるのが特徴。首・肩の痛みを伴うことも多い

# 6つの原因を比較する — 「どの指か」と「悪化状況」が核心

| 疾患名      | しびれる部位            | 悪化状況              | その他          |
|----------|-------------------|-------------------|--------------|
| 手根管症候群   | 親指・人差し指・中指（小指は正常） | 夜間～早朝 / 手首屈曲姿勢    | 40～60代女性多い   |
| 胸郭出口症候群  | 小指・薬指側 / 前腕内側     | 腕を上げたとき / 重い荷物    | なで肩の女性に多い    |
| 肘部管症候群   | 小指・薬指（半分）         | 肘を曲げ続けると悪化        | 進行で鷲手変形      |
| 頸椎症性神経根症 | 手指～前腕～上腕まで広がる     | 首の後屈（Spurling）で誘発 | 50代以降 肩の痛み伴う |
| 橈骨神経麻痺   | 手背・親指～中指の背側       | 上腕圧迫翌朝に出現         | 下垂手 多くは自然回復  |
| 脳卒中      | 手全体～顔・下肢まで同側に     | 突然発症（数秒～数分）       | 麻痺・言語障害を伴う   |

# 受診を考えるサイン — こんなときは専門医へ

しびれが毎晩・毎朝繰り返される

しびれが手首から肩・首まで広がっている

しびれが日中もある（夜間・朝だけでなくった）

両手に同時にしびれがある

手に力が入りにくい・物を落としやすくなった

症状が数か月以上続いている

手の筋肉がやせてきた（手のひらのふくらみが減った）

しびれとともに首や肩の痛みが強い

# これは救急！ — 脳卒中のしびれを見逃さない

## F

**Face**（顔のゆがみ）

顔がゆがむ・口が動きにくい

## A

**Arm**（腕の麻痺）

腕に力が入らない

## S

**Speech**（言語障害）

言葉が出ない・相手の言葉がわからない

## T

**Time**（すぐ119番！）

疑ったら今すぐ救急車を呼ぶ

## すぐ119番すべきしびれのサイン

突然始まったしびれ（数秒～数分で完成） ／ しびれ＋手足の麻痺 ／ 顔のゆがみ ／ 言葉が出ない

ひどい頭痛が同時に出了 ／ 視野の一部が欠ける・二重に見える

脳卒中治療のウィンドウは発症から**4.5時間以内** — 「様子を見よう」では間に合わない

## まとめ — Take Home Message

1

「どの指か」「いつ悪化するか」が鑑別の核心。小指が入るかどうかが最初の分岐点

2

最も多いのは手根管症候群（正中神経圧迫）。小指にしびれが出ないのが特徴

3

手の筋萎縮・力の低下・日中も続くしびれは早めの受診サイン

4

突然発症のしびれ＋麻痺・言語障害・顔のゆがみは脳卒中 → 即119番！